

Model: B2B · Cập nhật: 2026-08-28 · Owner phiên hợp: Product Lead (Đỗ Quý Đức)

Chẩn đoán: Bệnh viện ký hợp đồng và trả tiền (5.200.000 đ/tháng + 3.500 đ/đơn hoàn tất) · được sĩ lâm sàng của chính bệnh viện đó là người dùng hằng ngày · đối tác HIS chỉ là kênh phân phối ăn 20% rev-share, không phải bên mua · MedSafe không có bề mặt nào chạm bệnh nhân.

North Star: Median time-to-first-value · hiện tại chưa có số (3 pilot đang chạy) · mục tiêu ≤30 ngày · trạng thái 🟡

CÂY ĐÈN 3 TẦNG

Tầng · ID	Metric và định nghĩa ngắn	Hiện tại · 🟢 / 🟡 / 🟠 · Nguồn	Nhịp · Owner	Báo trước cho · Luật
L · L-01	Time-to-first-value — ngày từ ký hợp đến 1.000 đơn đạt QA, median theo cohort	chưa có số · ≤30 / 31–60 / >60 ngày · [TB]	Mỗi khách · Product Lead	POC-to-paid, NRR · R-01
L · L-02	Cảnh báo bị được sĩ bỏ qua — alert dismiss ÷ alert hiển thị, đo trên widget HIS	2,8% (Eval 1.500 ca) · ≤3,5 / 3,6–6,0 / >6,0% · [TB]	Tuần · Clinical Quality Lead	Usage depth, NRR · R-02
L · L-03	Bệnh viện partner-sourced go-live ≤30 ngày ÷ số bệnh viện được giới thiệu	chưa có số · ≥60 / 40–59 / <40% · [TB]	Tuần · Kỹ sư Tích hợp	POC-to-paid, MRR · R-03
O · O-01	Usage depth — được sĩ có ≥1 phiên duyệt đơn/tuần ÷ được sĩ được cấp quyền	chưa có số · ≥60 / 30–59 / <30% · [TB]	Tuần · Customer Success	NRR, gia hạn · R-02
O · O-02	Chi phí AI/đơn hoàn tất — (token + retry) ÷ đơn hoàn tất	0,0042 USD (110 đ) · ≤0,0080 / 0,0081–0,0250 / >0,0250 USD · [MH] MH-01	Tuần · FinOps	Gross margin · R-04
O · O-03	POC → paid — pilot ký trả phí ÷ pilot kết thúc (đủ 10.000 đơn)	0/3 chưa kết thúc · ≥50 / 35–49 / <35% · [BM] ICONIQ GTM 2026	Quý · Business Development	MRR, payback · R-03
G · G-01	Tập trung doanh thu — doanh thu bệnh viện lớn nhất ÷ tổng doanh thu	100% (1 pilot) · <20 / 20–30 / >30% · [TB]	Tháng · Finance	Rủi ro doanh thu · R-05
G · G-02	GM sau rev-share 20% HIS — (DT – COGS – rev-share) ÷ DT, theo từng bệnh viện	65,7% (mô hình) · ≥65 / 55–64,9 / <55% · [MH] MH-02	Quý · Finance	Runway, payback · R-05

LUẬT QUYẾT ĐỊNH

ID	NEU · TRONG · VÀ	THÌ	KHÔNG THÌ	DỪNG?
R-01	TTFV >60 ngày · 2 cohort go-live liên tiếp · ≥3 bệnh viện đã ký/cohort	Đóng băng ký hợp đồng mới 30 ngày; cắt pilot xuống 1 khoa được ngoại trú, 1 luồng đơn, tới khi median <30 ngày	Không tuyển thêm sales, không mở pilot ra toàn viện để bù tiến độ	CÓ
R-02	Cảnh báo bị bỏ qua >6,0% · 3 tuần liên tiếp · ≥3.000 cảnh báo hiển thị	Khoá phát hành rule mới; chuyển cảnh báo mức trung bình sang chế độ im lặng; chạy lại Eval 1.500 ca trước khi bật lại	Không mở rộng bệnh viện mới khi tỷ lệ báo động giả còn trên ngưỡng đỏ	KHÔNG
R-03	Partner-sourced go-live <40% · 60 ngày · ≥5 bệnh viện được giới thiệu	Dừng ký đối tác HIS mới; dồn kỹ sư tích hợp vào kích hoạt bệnh viện đã giới thiệu; đàm phán lại minimum commitment với Infomed	Không dùng "số partner đã ký" làm chỉ số tăng trưởng trong bất kỳ báo cáo nào	CÓ
R-04	Chi phí AI/đơn >0,0250 USD · 2 tuần liên tiếp · ≥5.000 đơn hoàn tất	Giới hạn context vào model; bật lại prompt caching toàn bộ Được thư Master; đàm phán lại quota trước kỳ billing kế tiếp	Không hạ tỷ lệ QA nội bộ 3% để làm cost/job trông thấp hơn	KHÔNG
R-05	GM sau rev-share <55% · 2 quý liên tiếp · ≥6 bệnh viện trả phí	Đàm phán lại rev-share xuống <15%, hoặc chuyển phần đơn vượt 1.000/tháng sang pass-through token cho bệnh viện	Không bù bằng cách ký thêm bệnh viện ở nguyên giá 3.500 đ/đơn	KHÔNG

CỔNG 90 NGÀY

Ngày	Một metric · ngưỡng	Evidence	Đạt / Trượt
30	Clinical Pilot Report được Hội đồng Được lâm sàng ký nghiệm thu · ≥2/3 bệnh viện pilot, mỗi báo cáo ≥10.000 đơn thật	Biên bản nghiệm thu có chữ ký Trưởng khoa Được + export audit log Langfuse theo mã đơn	GO / FIX
60	Median time-to-first-value · ≤30 ngày trên ≥3 bệnh viện	Event log kickoff và mốc 1.000 đơn đạt QA, export riêng theo contract ID	GO / PIVOT
90	Gross margin sau rev-share 20% HIS · ≥55% trên ≥6 bệnh viện trả phí và 40.000 đơn hoàn tất	Billing export ghép hoá đơn token, hoá đơn rev-share Infomed, QA report nội bộ	GO / KILL

Kill criteria: Dừng hẳn hướng partner-led qua HIS vào **2026-11-26** (ngày 90) nếu **cả hai** cùng đúng: GM sau rev-share vẫn <55% sau một vòng đàm phán lại tỷ lệ chia, **và** chưa đủ 4 bệnh viện trả phí đạt TTFV <45 ngày. Khi đó giả định gốc "đối tác HIS rút ngắn đường vào bệnh viện" đã sai → cắt toàn bộ chi phí kênh, chuyển sang bán trực tiếp bệnh viện tư, hoặc dừng dự án nếu 3 tháng bán trực tiếp không ký được hợp đồng nào.

Chưa đo được: TTFV (chưa bệnh viện nào đi trọn từ ký đến 1.000 đơn QA) · cần gắn event kickoff + mốc QA vào Langfuse, backfill 3 pilot · owner Product Lead · có số 2026-09-30 — CAC thật kênh partner-led (Day 25 mới có ước lượng 2.500 USD) · owner Lead BD · 2026-10-15 — Usage depth (chưa tách user_id được sĩ khỏi API hệ thống) · owner Kỹ sư Tích hợp · 2026-09-18 — Unit economics dài hạn (file Day 24 dựng cho SmartStudy AI, không dùng lại được) · owner Đỗ Quý Đức · 2026-10-31.

PHỤ LỤC — HAI NGƯỠNG SUY TỪ MÔ HÌNH

ID	Metric	Input Day 24–25	Phép tính	Kết quả và ngưỡng áp dụng
MH-01	Trần chi phí AI trên mỗi đơn thẩm định hoàn tất	Giá bán 0,1346 USD/đơn hoàn tất; gross margin usage mục tiêu 60% (ngưỡng sống còn Day 25 tab 2_Pricing); chi phí biến đổi phí-AI gồm hạ tầng 60,10 USD/tháng và QA nội bộ 75,00 USD/tháng; mẫu số 8.400 đơn hoàn tất/tháng ở containment 84%	$0,1346 \times (1 - 0,60) = 0,05384$ và $(60,10 + 75,00) \div 8.400 = 0,01608$ nên trần AI = $0,05384 - 0,01608 = 0,03776$ USD/đơn	Trần tuyệt đối 0,0378 USD/đơn. Đèn O-02 đặt đỏ ở 0,0250 USD tức 66% trần, chừa buffer cho kịch bản containment rơi về 60%: khi đó mẫu số còn 6.000 đơn, chi phí phí-AI phân bổ lên $135,10 \div 6.000 = 0,02252$ USD/đơn và trần AI tụt còn $0,05384 - 0,02252 = 0,0313$ USD/đơn, vẫn cao hơn mức đỏ. Baseline hiện tại 0,0042 USD/đơn nên xanh đặt ở 0,0080 USD, khoảng 1,9 lần baseline
MH-02	Gross margin sau rev-share 20% cho đối tác HIS	Doanh thu tháng một bệnh viện tiêu chuẩn: phí nền 200 USD cộng 7.400 đơn vượt quota 1.000 đơn nhân 0,1346 USD; COGS trực tiếp 170,57 USD/tháng từ tab 1_Cost_Job; overhead R&D và support 200,00 USD/tháng; tỷ lệ rev-share 20% doanh thu theo tab 4_Channel_Fit	Doanh thu = $200 + 7.400 \times 0,1346 = 1.196,04$ USD; rev-share = $0,20 \times 1.196,04 = 239,21$ USD; GM sau rev-share = $(1.196,04 - 170,57 - 239,21) \div 1.196,04 = 786,26 \div 1.196,04 = 0,657$; GM full-loaded sau rev-share = $(1.196,04 - 370,57 - 239,21) \div 1.196,04 = 0,490$	65,7% là mức mô hình hiện tại, thấp hơn 84,9% của Day 25 đúng 19,2 điểm phần trăm vì Day 24–25 chưa trừ rev-share. Đèn G-02 đặt xanh từ 65%, đỏ dưới 55%: dưới 55% thì bán full-loaded rơi xuống khoảng 38% và không còn nuôi nổi chi phí kênh, nên đó là điểm phải đàm phán lại tỷ lệ chia theo luật R-05

CHƯA ĐO ĐƯỢC

Đèn hoặc giả định	Cần gì để đo	Ai chịu trách nhiệm	Ngày có số
Time-to-first-value — chưa bệnh viện nào đi trọn từ ngày ký đến mốc 1.000 đơn đạt QA	Gắn event kickoff và event mốc 1.000 đơn đạt QA vào Langfuse, backfill thủ công cho 3 pilot Infomed đang chạy	Product Lead (Đỗ Quý Đức)	2026-09-30
CAC thực tế của kênh partner-led — Day 25 mới có ước lượng 2.500 USD chưa có hoá đơn	Cộng chi phí kỹ sư tích hợp theo giờ, chi phí pre-sales và phí trả trước cho đối tác HIS, gắn theo contract ID của 3 hợp đồng đầu	Lead Business Development	2026-10-15
Usage depth — event log chưa tách lượt được sẽ mở widget khỏi lượt gọi API hệ thống	Gắn user_id được sẽ vào event mở widget trong HIS và dựng bảng weekly active theo từng tài khoản bệnh viện	Kỹ sư Tích hợp	2026-09-18
Unit economics dài hạn (LTV, CAC payback, NPV, runway) — file Day 24 dựng cho sản phẩm SmartStudy AI, không dùng lại được	Dựng lại mô hình 36 tháng theo hợp đồng bệnh viện, chu kỳ mua sắm y tế và tỷ lệ gia hạn thực tế thay vì churn tiêu dùng	Đỗ Quý Đức	2026-10-31

GHI NHẬN AI CRITIQUE

Phản biện	Chấp nhận hay bác bỏ	Thay đổi đã thực hiện	Lý do
Gross margin 84,9% trong Day 25 là con số trước rev-share, dashboard đang khoe một biên không tồn tại	Chấp nhận	Thay đèn Gross Margin bằng Gross margin sau rev-share và dựng MH-02 để tính lại còn 65,7%, full-loaded 49,0%	Đối tác HIS lấy 20% doanh thu định kỳ là chi phí chắc chắn xảy ra, không phải rủi ro giả định
Nên dùng benchmark NRR trung vị 101% của Benchmarkit làm đèn kết quả cho đủ bộ	Bác bỏ	Giữ Tập trung doanh thu làm đèn kết quả thứ hai, đưa NRR vào phần chưa đo được	MedSafe chưa có bệnh viện nào đủ 12 tháng hợp đồng nên NRR sớm nhất có số vào 2027-08-31, đặt đèn bây giờ chỉ là trang trí
Với 100% GTM đặt vào một kênh partner, thiếu đèn nào bắt được việc partner ký rồi không đẩy	Chấp nhận	Thêm L-03 đo tỷ lệ bệnh viện partner-sourced go-live trong 30 ngày và luật dừng R-03 cấm dùng số partner đã ký làm chỉ số tăng trưởng	Day 25 chốt partner-led 29/30 điểm nhưng chưa partner nào ký, đây là giả định lớn nhất chưa có đèn canh